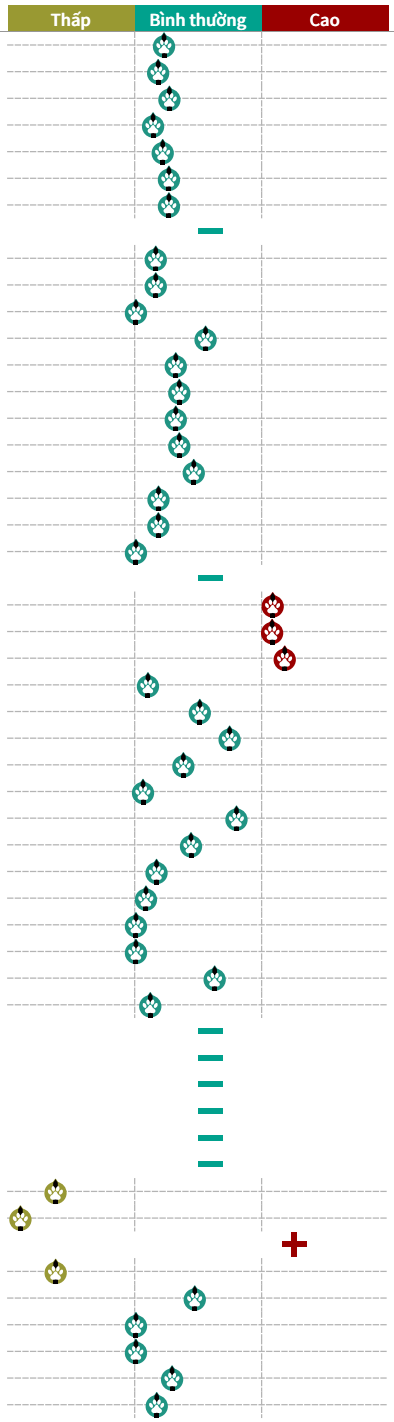
BVTY Solpet

Báo Cáo Các Thành Phần Hình Thành Trong Máu 52 Mục

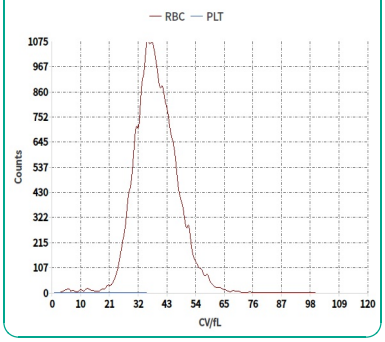
No.: 260325002	Vật mẫu: Máu(1x)	Tên thú cưng: Mon	Giống loài: Mèo	Giới tính: M
L I S :	Bác sĩ: Quản trị viên	Chủ nuôi: Anh Duc	Tuổi thú cưng : 1Y6M	Cân nặng: kg

Tham số

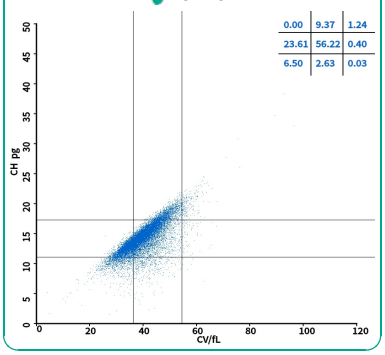
Các mục phát hiện	Kết quả	Đơn vị	Thang đo
1.WBC(WBC)	6.72	10^9/L	3.5-17.9
1-1.NEU#(NEU#)	4.12	10^9/L	2.3-12.58
1-2.NST#(NST#)	0.21	10^9/L	0-0.8
1-3.NSG#(NSG#)	3.69	10^9/L	2.3-12.5
1-4.NHG(NSH#)	0.21	10^9/L	0-1
1-5.LYM#(LYM#)	2.27	10^9/L	0.73-6.6
1-6.Số lượng tuyệt đối lympho nhỏ(SLYM#)	2.27	10^9/L	0.73-6.6
1-7.Số lượng tuyệt đối lympho lớn(LLYM#)	0.00	10^9/L	0-0
1-8.MON#(MON#)	0.14	10^9/L	0-0.9
1-9.EOS#(EOS#)	0.19	10^9/L	0-1.2
1-10.BAS#(BAS#)	0.00	10^9/L	0-0.12
1-11.NEU%(NEU%)	61.27	%	38-80
1-12.Bạch cầu trung tính dạng gậy %(NST/WBC)	3.17	%	0-10
1-13.Bạch cầu trung tính dạng gậy %(NST/NEU)	5.17	%	0-15
1-14.Bạch cầu trung tính tăng phân đoạn %(NSH/WBC)	3.17	%	0-10
1-15.Bạch cầu trung tính tăng phân đoạn %(NSH/NEU)	5.17	%	0-15
1-16.LYM%(LYM%)	33.80	%	20-50
1-17.MON%(MON%)	2.11	%	1-7.2
1-18.EOS%(EOS%)	2.82	%	1-11.2
1-19.BAS%(BAS%)	0.00	%	0-0.2
1-20.Số lượng tuyệt đối bạch cầu bất thường(AWBC#)	0.00	10^9/L	0-0
2.RBC(RBC)	13.18	10^12/L	5.6-12.6
2-1.HGB(HGB)	186.95	g/L	98-178
2-2.HCT(HCT)	52.73	%	26-47
2-3.MCV(MCV)	40.02	fL	38.7-52.5
2-4.MCH(MCH)	14.19	pg	11.8-16.5
2-5.MCHC(MCHC)	354.52	g/L	280-380
2-6.Độ phân bố kích thước hồng cầu(RDW-SD)	22.00	fL	16-31.9
2-7.Độ phân bố kích thước hồng cầu(RDW-CV)	15.99	%	15.5-24.2
2-8.Độ phân bố hàm lượng hemoglobin trong hồng cầu(HDW-SD)	9.00	g/L	5.8-9.8
2-9.Độ phân bố hàm lượng hemoglobin trong hồng cầu(HDW-CV)	17.49	%	13.2-23
2-10.RET#(RET#)	1.57	10^9/L	0-9.6
2-11.RET%(RET%)	0.01	%	0-0.15
2-12.NRBC#(NRBC#)	0.00	10^9/L	0-0
2-13.NRBC/WBC%(NRBC/WBC)	0.00	%	0-0
2-14.ETG#(ETG#)	37.57	10^9/L	0-60
2-15.ETG%(ETG%)	0.29	%	0-2.5
2-16.Số lượng hồng cầu hình cầu(SPH#)	3.72	10^9/L	0-193.66
2-17.Tỷ lệ hồng cầu hình cầu(SPH%)	0.03	%	0-2.71
2-18.Số lượng hồng cầu gai(ACA#)	0.00	10^9/L	0-0
2-19.AGG#(AGG#)	0.00	10^9/L	0-0.15
2-20.Số lượng thể Heinz(HEB#)	0.00	10^9/L	0-0
2-21.Tỷ lệ thể Heinz(HEB%)	0.00	%	0-0
3.Tổng số tiểu cầu(EPLT)	52.68	10^9/L	140-547
3-1.Số lượng tuyệt đối tiểu cầu(PLT#)	12.72	10^9/L	140-547
3-2.APLT#(APLT#)	1.52	10^9/L	0-0.15
3-3.PCT(PCT)	0.08	%	0.2-0.8
3-4.MPV(MPV)	14.33	fL	8.2-21.3
3-5.LPLT#(LPLT#)	0.00	10^9/L	0-103
3-6.P-LCR(LPLT/EPLT)	0.00	%	0-30
3-7.Độ phân bố kích thước tiểu cầu(PDW-SD)	14.00	fL	7.1-31.1
3-8.Độ phân bố kích thước tiểu cầu(PDW-CV)	48.61	%	43.7-73.4



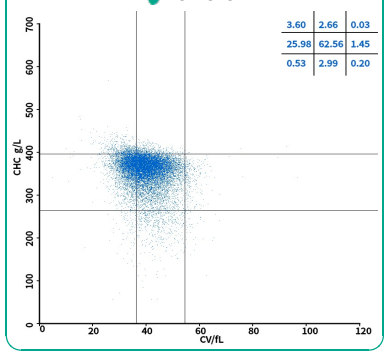
PLT-RBC



CH-CV



CHC-CV

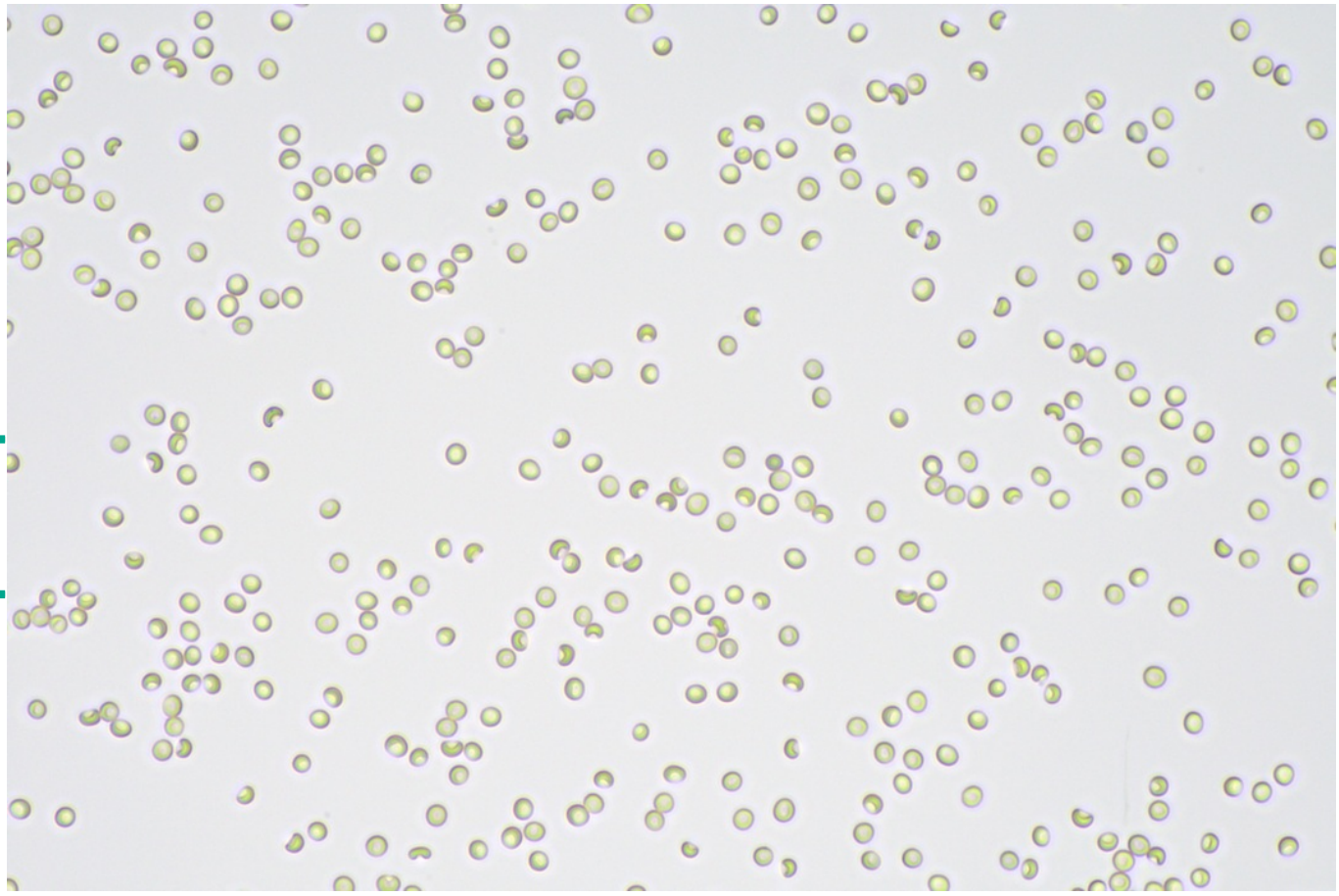


BVTY Solpet

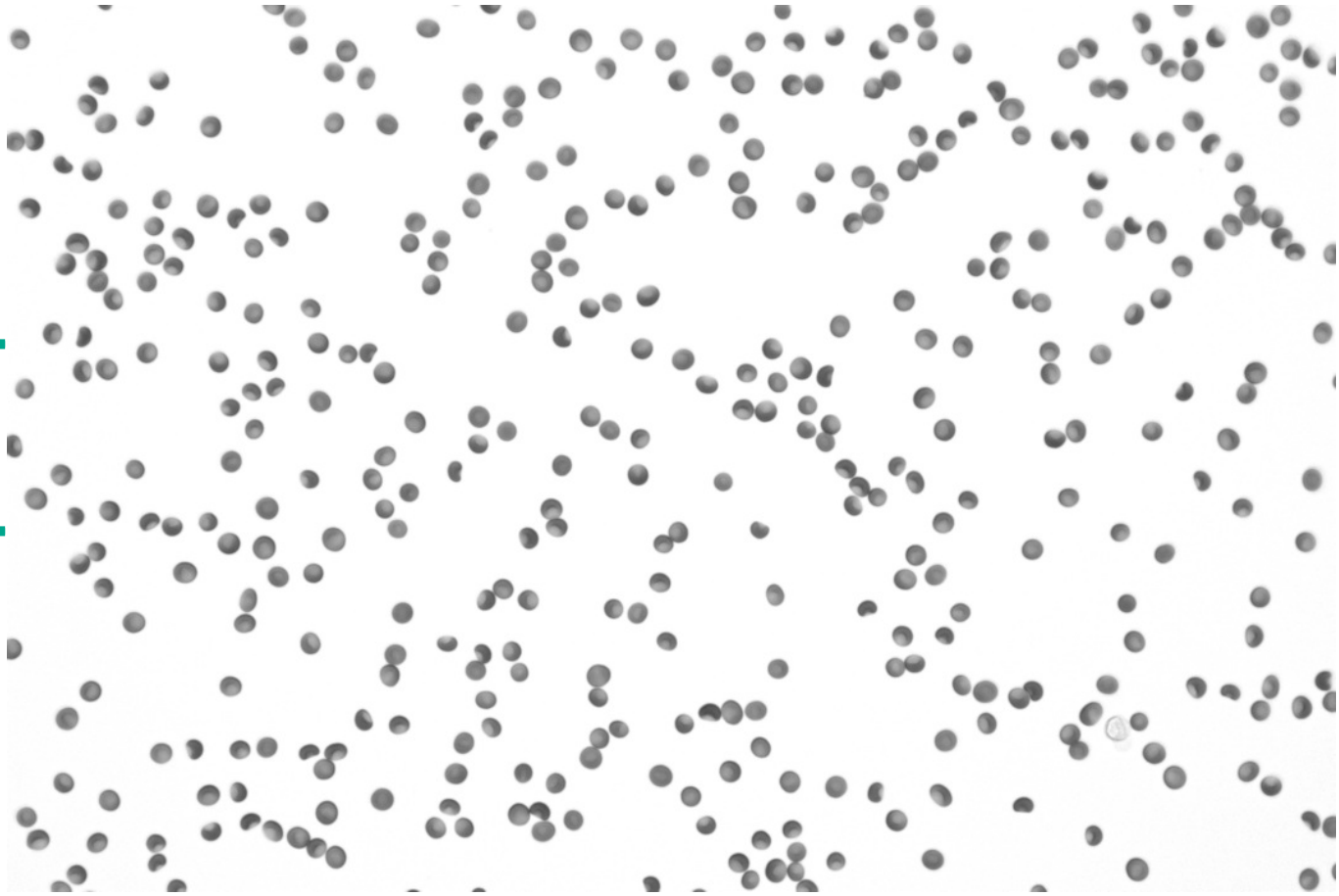
Báo cáo hình thái máu

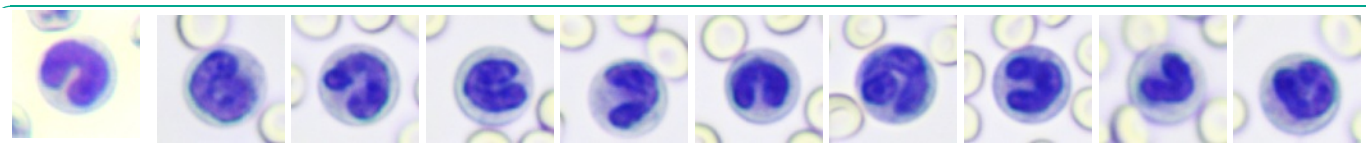
No.: 260325002	Vật mẫu: Máu(1x)	Tên thú cưng: Mon	Giống loài: Mèo	Giới tính: M
L I S :	Bác sĩ: Quản trị viên	Chủ nuôi: Anh Duc	Tuổi thú cưng : 1Y6M	Cân nặng: kg

Hình ảnh phân phối RBC & PLT



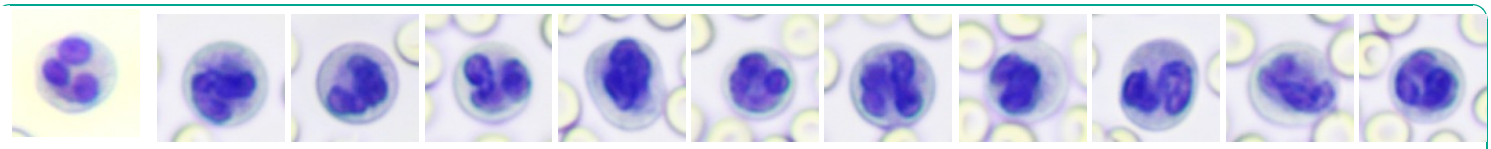
Hình ảnh phân phối HGB





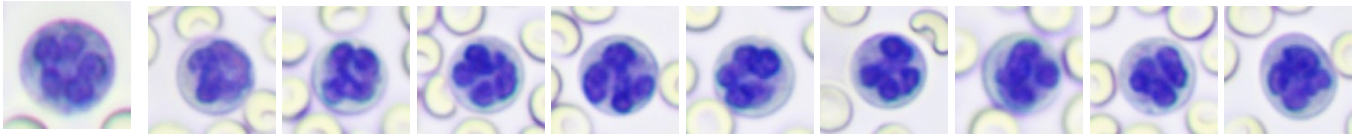
NST

Qty .:9/378Ảnh | Nồng độ:0.21 x 10^9/L | PCT:3.17



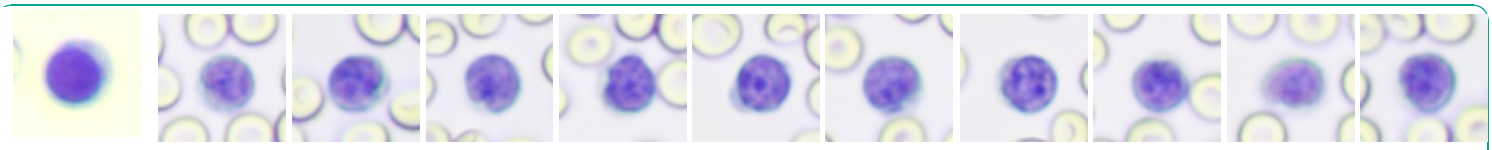
NSG

Qty .:156/378Ảnh | Nồng độ:3.69 x 10^9/L | PCT:54.93



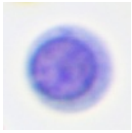
NSH

Qty .:9/378Ảnh | Nồng độ:0.21 x 10^9/L | PCT:3.17



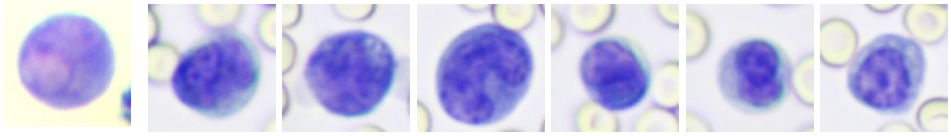
SLYM

Qty .:96/378Ảnh | Nồng độ:2.27 x 10^9/L | PCT:100.00



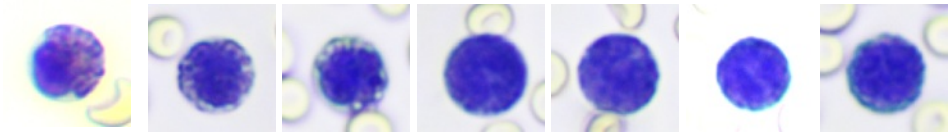
LLYM

Qty .:0/378Ảnh | Nồng độ:0.00 x 10^9/L | PCT:0.00



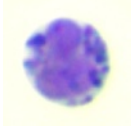
Bạch cầu mono

Qty .:6/378Ảnh | Nồng độ:0.14 x 10^9/L | PCT:2.11



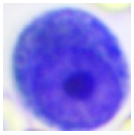
Bạch cầu ái toan

Qty .:8/378Ảnh | Nồng độ:0.19 x 10^9/L | PCT:2.82



Bạch cầu ái kiềm

Qty .:0/378Ảnh | Nồng độ:0.00 x 10^9/L | PCT:0.00



Bạch cầu bất thường

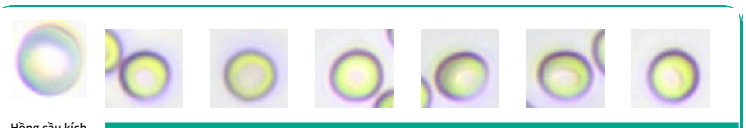
Qty .:0/378Ảnh | Nồng độ:0.00 x 10^9/L | PCT:0.00

Hồng cầu bình thường

Qty .:13415/56Ảnh | Nồng độ:7.75 x 10^12/L | PCT:78.47

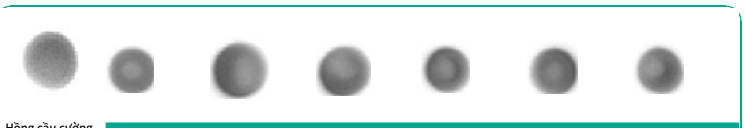
Hồng cầu bình thường

Qty .:14604/48Ảnh | Nồng độ:9.85 x 10^12/L | PCT:83.96



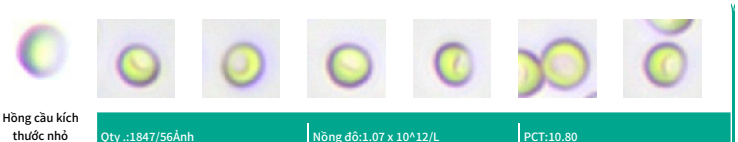
Hồng cầu kích thước lớn

Qty .:1833/56Ảnh | Nồng độ:1.06 x 10^12/L | PCT:10.72



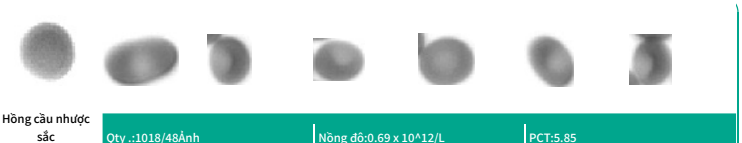
Hồng cầu cường sắc

Qty .:1771/48Ảnh | Nồng độ:1.19 x 10^12/L | PCT:10.18



Hồng cầu kích thước nhỏ

Qty .:1847/56Ảnh | Nồng độ:1.07 x 10^12/L | PCT:10.80



Hồng cầu nhược sắc

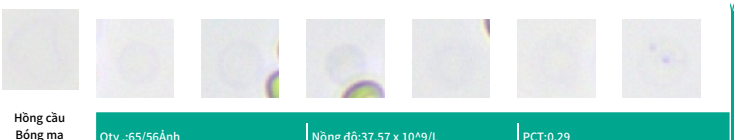
Qty .:1018/48Ảnh | Nồng độ:0.69 x 10^12/L | PCT:5.85

Hồng cầu lưới

Qty .:11/60Ảnh | Nồng độ:1.57 x 10^9/L | PCT:0.01

NRBC

Qty .:0/378Ảnh | Nồng độ:0.00 x 10^9/L | PCT:0.00



Hồng cầu Bóng ma

Qty .:65/56Ảnh | Nồng độ:37.57 x 10^9/L | PCT:0.29

Hồng cầu hình cầu

Qty .:26/60Ảnh | Nồng độ:3.72 x 10^9/L | PCT:0.03

Kết tụ hồng cầu

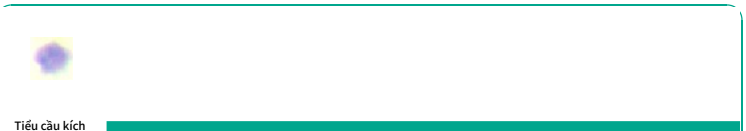
Qty .:0/60Ảnh | Nồng độ:0.00 x 10^9/L | PCT:0.00

Hồng cầu gai

Qty .:0/60Ảnh | Nồng độ:0.00 x 10^9/L | PCT:0.00

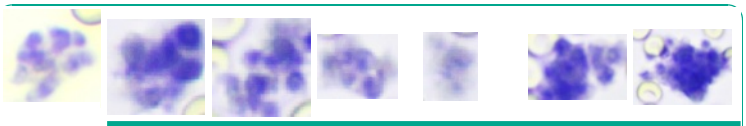
Thể Heinz

Qty .:0/60Ảnh | Nồng độ:0.00 x 10^9/L | PCT:0.00



Tiểu cầu kích thước lớn

Qty .:0/56Ảnh | Nồng độ:0.00 x 10^9/L | PCT:0.00



Tiểu cầu kết cụm

Qty .:67/378Ảnh | Nồng độ:1.52 x 10^9/L | PCT:2.89

Gợi ý chẩn đoán

1. 【RBC>12.60】Thường gặp trong các bệnh liên quan đến mất nước, tăng hoặc bệnh bệnh lý của erythropoietin, tăng huyết áp, đa hồng cầu thực sự, v.v.
2. 【HGB>178.00】Thường gặp trong các bệnh liên quan đến mất nước, tăng hoặc bệnh bệnh lý của erythropoietin, tăng huyết áp, đa hồng cầu thực sự, v.v.
3. 【HCT>47.00】Thường gặp trong mất nước, sử dụng catecholamine, sự gia tăng bù đắp hoặc bệnh lý của erythropoietin, tăng huyết áp, cường giáp, phì đại chi, v.v.
4. 【PLT#<140.00】Nguyên nhân thường gặp: 1. Tập hợp mẫu: ① Tập hợp tiểu cầu sinh lý, thường gặp ở mèo; ② Kháng đông không đủ sau lấy mẫu: tỷ lệ máu-kháng đông không đúng, trộn máu không đủ với kháng đông, quá trình lấy máu khó khăn, hoặc chọn sai kháng đông (ví dụ: heparin); ③ Bảo quản kéo dài 2. Tăng tiêu thụ: xuất huyết, purpura, đông máu nội mạch lan tỏa (DIC) 3. Nhiễm trùng: Ehrlichia, Leishmania, virus suy giảm miễn dịch mèo (FIV), virus leukemia mèo (FeLV) 4. Giảm tiểu cầu do miễn dịch 5. Lách to: nhiễm trùng lách, bệnh tự miễn, u lách, xoắn lách 6. Ngộ độc thuốc hoặc độc tố 7. Rối loạn tăng sinh tủy xương. Các bước tiếp theo được khuyến nghị: 1. Loại trừ nguyên nhân liên quan đến tập hợp mẫu 2. Xét nghiệm chỉ số viêm: fSAA 3. Xét nghiệm sinh hóa: đánh giá chức năng gan và thận 4. Hình ảnh học (siêu âm hoặc X-quang): loại trừ xuất huyết nội tạng, đánh giá gan, thận, lách và kiểm tra u 5. Sàng lọc nhiễm trùng: FeLV, FIV, Ehrlichia 6. Hồ sơ đông máu
5. 【PCT<0.20】Cho thấy giảm tiểu cầu.
6. 【APLT#>0.15】Thường liên quan đến tập hợp tiểu cầu vi thể không nhìn thấy bằng mắt thường. Nguyên nhân tập hợp mẫu: 1. Tập hợp tiểu cầu sinh lý, thường gặp ở mèo 2. Kháng đông không đủ sau lấy mẫu 3. Bảo quản kéo dài. Nguyên nhân bệnh lý thường gặp bao gồm giảm tiểu cầu do miễn dịch, azotemia, bệnh nhiễm trùng, u ác tính, bệnh tim hoặc rối loạn do thuốc. Bước tiếp theo được khuyến nghị: Loại trừ lỗi xử lý mẫu và các hiện tượng kỹ thuật. Nếu không xác nhận bất thường trong xử lý mẫu, tiến hành chẩn đoán phân biệt theo hướng bệnh lý.
7. 【RBC>12.60 HGB>178.00 HCT>47.00】Thường gặp trong bệnh đa hồng cầu, mất nước, v.v.